EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 77224
SERVICIO : MEL MUJERES HSC
FECHA : 2024-01-11 14:40:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LUIS JOEL GAJARDO SEPULVEDA			RUN	: 3.455.034-4
F.Nac	: 15-02-1937	Edad	: 86 AÑOS, 10 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: CHACABUCO 1346 *ACT*			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-01-09	Fecha Egreso	: 2024-01-11 14:40:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. C61.X-TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Insuficiencia respiratoria aguda resuelta
2. Epoc exacerbado
a. Neumonia ATS III
3. Cancer de próstata en Hormonoterapia
a. En cuidados paliativos
4. Anemia moderada hipocromica microcitica mixta
5. FA paroxística TACO suspendido
6. ICC
7. HTA
8. DM 2
9. Dependiente
10. Institucionalizado

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J44.9-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. C61-TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente masculino de 86 años, con antecedentes descritos es traido el 07/01 al Hospital de San Carlos por cuadro de CEG de dos días de evolución, desatura hasta 70% por lo que inician O2 5L/min saturando 89-90% al ingreso y disnea que exacerba ese dia. Al ingreso paciente afebril, hipotenso 83/47, hiporreactivo. Se solicitan laboratorios que evidencian aumento de parámetros inflamatorios. Se inicia volemización, tratamiento antibiótico, broncodilatación y kinesioterapia. Se solicitan TAC de cerebro y de pulmón s/c. TC De cerebro sin lesiones agudas, TC de pulmón compatible con focos de condensación infecciosos bibasales. Se decide hospitalización.
Paciente en el servicio de medicina estable, afebril, con disminución de parámetros inflamatorios, con disminución de los parámetros inflamatorios, actualmente sin O2 por mas de 24 h, por lo que se continuar tratamiento con hospitalización domiciliaria.

INDICACIONES AL ALTA

1. 1. Regimen enteral fresubin a 30cc/h SNG
2. 2. Agua libre por SNG 200 cc cada 6 h
3. 3. Azitromicina 500 mg cada dia (3/5)

4. 4. Ceftriaxona 2 g EV cada dia (5/7) hasta sábado 13/01
5. 5. Berodual (Bromuro de ipatropio/fenoterol) 4 puff c/6h por AEC
6. 6. Salmeterol fluticasona 2 puff c/12h por AEC
7. 7. Sulfato ferroso 200 mg cada dia por SNG iniciar el 14/01
8. 8. Zolpidem 10 mg cada noche SNG
9. 9. Tamsulosina 0.4 mg cada dia por SNG
10. 10. Quetiapina 50 mg cada dia por SNG
11. 11. Kinesioterapia respiratoria y motora
12. 12. Terapia fonoaudiología para retiro de sonda SNE
13. 13. Retomar controles crónicos habituales
14. 14. En caso de aumento de disnea, cianosis, desaturación consultar en SU.

EXÁMENES Y RESULTADOS

07/01: LEUCOCITOS 18500 PCR 186,5 crea 1.3, lactato 7.4,Na 134, K 5.1, Cl 96,m Hb 8.9, plaquetas 443.000, INR 1.29, Tp 17 seg, troponina 3.6. GSA: PH 7.46, PCO2 27.1, PO2 63.2, HCO3 19.4, Sat 88%
10/01: Leucocitos 17.800, plaquetas 398.000, Hb 8.1, VHS 70, retitulocitos 1.0, ferritina 32.9, albumina 3.0, Crea 0.5, Ca 8.4, PCR 138.9, BUN 19, Transferrina 183.2, fierro 44, Na 134, K 3.6, Cl 101

Jorge Andres Villa Flores
MEDICO TRATANTE
16178692-N

JEFE SERVICIO